

Adaptation de la surveillance basée sur les événements utilisant des sources ouvertes : guide pratique pour les rassemblements de masse



Organisation
mondiale de la Santé

Adaptation de la surveillance basée sur les événements utilisant des sources ouvertes : guide pratique pour les rassemblements de masse



Organisation
mondiale de la Santé

Adaptation de la surveillance basée sur les événements utilisant des sources ouvertes : guide pratique pour les rassemblements de masse [Tailoring event-based surveillance using open sources: practical guide for mass gathering]

ISBN 978-92-4-010780-9 (version électronique)

ISBN 978-92-4-010781-6 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2025

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci-dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Adaptation de la surveillance basée sur les événements utilisant des sources ouvertes : guide pratique pour les rassemblements de masse [Tailoring event-based surveillance using open sources: practical guide for mass gathering]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025. Licence : [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Photo de couverture : Le week-end le long de la promenade de la plage de Galle Face à Colombo, Sri Lanka.

© OMS / Conor Ashleigh.

Table des matières

Remerciements	iv
Abréviations	v
Introduction	1
Méthodologie	2
Guide étape par étape pour adapter l'EBS utilisant des sources ouvertes aux rassemblements de masse	3
Étape 1 : Détermination des maladies, syndromes et dangers prioritaires	4
Étape 2 : Évaluation de l'EBS existante utilisant des sources ouvertes	6
Étape 3 : Identification des sources d'information et des plateformes pour la surveillance	7
Étape 4 : Mise en place ou renforcement du mécanisme de partage des informations	10
Étape 5 : Établissement de modes opératoires normalisés, formation et essais	11
Étape 6 : Mise en œuvre d'une EBS adaptée à l'événement	12
Exemples de pays ayant fait l'expérience de rassemblements de masse	13
Références bibliographiques	14

Remerciements

Le présent document a été établi par l'Unité Santé aux frontières et rassemblements de masse du Département Renforcement de la préparation des pays, qui relève du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le texte principal a été rédigé par Amaia Artazcoz Glaria et Manami Yanagawa, sous la supervision de Ninglan Wang. Le personnel de l'unité Veille en santé publique du Département Coordination des alertes et de la riposte, qui dirige la surveillance mondiale basée sur les événements (EBS) de routine et spécifique aux rassemblements de masse au sein du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire, a grandement contribué à l'élaboration de ce document : Adedoyin Abiola Awofisayo-Okuyelu, Blanche Johanna Greene-Cramer et Kaja Kaasik-Aaslav, sous la supervision d'Esther Hamblion. Nous remercions nos collègues de l'unité Biosécurité et protection de la sécurité sanitaire, au sein du Département Prévention et préparation aux épidémies et pandémies du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire : Sophie Allain Iloos, sous la supervision de Nahoko Shindo.

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos collègues des bureaux régionaux de l'OMS, notamment Raul Garcia Acevedo, Jose Antonio Montes, Camilo Avila, Viviana Guzman, Christian Hertlein, Florence Heuschen, Ezequiel Travin et Katia Uchimura du Bureau régional des Amériques ; Farida Abougazia et Fatima Arifi du Bureau régional de la Méditerranée orientale ; Maung Maung Htike du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ; et May Chiew, Harsh Lata, Ji Yong Lee, Viema Lewagalu Biauikul et Satoshi Shimada du Bureau régional du Pacifique occidental.

Nous exprimons également notre gratitude aux spécialistes des rassemblements de masse et de l'unité Veille en santé publique : Christie Manthey, Valerie Mize, Dallas Rohraff, Stephanie Fazekas Salyer et Emily Weston des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d'Amérique (cette collaboration a eu lieu avant le 20 janvier 2025) ; Xanthi Andrianou, Jon Bilbatua et Gianfranco Spiteri du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), en Suède ; Viviane Kuissi et Gerry Geoffrey Mtike de l'Organisation internationale pour les migrations, au Kenya ; Sujeet Kr. Singh du Ministère de la santé et du bien-être de la famille du gouvernement indien ; et les référent(e)s des centres collaborateurs de l'OMS pour les rassemblements de masse et la sécurité sanitaire mondiale, à savoir Paul Arbon de l'Université Flinders en Australie, Lucia Mullen du Johns Hopkins Center for Health Security aux États-Unis d'Amérique, Anas Abdulhafeez Khan du Ministère de la santé d'Arabie saoudite et Tina Endericks de la Health Security Agency au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Ces apports techniques ont eu lieu en 2024.

Déclaration d'intérêts des contributrices et contributeurs externes

Chaque contributrice ou contributeur externe ayant agi à titre individuel a soumis à l'OMS une déclaration d'intérêts faisant état de conflits d'intérêts potentiels susceptibles d'affecter, ou d'être raisonnablement perçus comme affectant, son objectivité et son indépendance par rapport à l'objet de ce document. L'OMS a examiné chacune des déclarations et a conclu qu'aucune ne pouvait donner lieu, ou être raisonnablement perçue comme pouvant donner lieu, à un conflit d'intérêts potentiel en rapport avec les sujets abordés dans ce document.

Abréviations

CBRN	chimique, biologique, radiologique et nucléaire
COVID-19	maladie causée par le virus SARS-CoV-2
EBS	surveillance basée sur les événements
EIOS	veille épidémique à sources ouvertes (Epidemic Intelligence from Open Sources)
EMM	Europe Media Monitor
EWAR	signalement précoce, alerte et riposte
IBS	surveillance basée sur les indicateurs
IMS	système de gestion des incidents
JEE	évaluation extérieure conjointe
OMS	Organisation mondiale de la Santé
RMISP	Réseau mondial d'information en santé publique
RSI	Règlement sanitaire international

Introduction

Selon la définition de l'OMS, les rassemblements de masse sont des événements caractérisés par la concentration de personnes en un lieu donné, dans un but précis et sur une période déterminée, qui peuvent mettre à rude épreuve les ressources de planification et de riposte des pays ou communautés hôtes. Selon le contexte, les rassemblements de masse peuvent exposer les personnes présentes et la population locale à un risque plus élevé d'événements de santé indésirables. Une flambée épidémique qui survient au sein d'un rassemblement de masse international ou pendant celui-ci a un potentiel accru de propagation mondiale. D'autres risques, tels que des conditions météorologiques extrêmes ou des événements délibérément provoqués, peuvent nécessiter des mesures de précaution spécifiques. Du fait que les rassemblements de masse s'accompagnent d'un afflux de personnes, ils peuvent mettre à rude épreuve les systèmes existants et submerger les capacités locales, y compris, mais sans s'y limiter, les ressources de laboratoire et les capacités d'intervention des hôpitaux. En outre, l'attention médiatique et politique suscitée par les rassemblements de masse peut se traduire par une amplification notable des conséquences néfastes d'un événement de santé indésirable. La mésinformation et la désinformation générées par diverses sources, notamment les médias sociaux, peuvent également avoir une incidence sur la sécurité des rassemblements de masse.

La veille sanitaire est essentielle pour le signalement précoce, l'alerte et la riposte (EWAR), et est vitale pour protéger la santé des populations dans le contexte des rassemblements de masse (1). Elle permet d'identifier, de collecter, de synthétiser, d'analyser, d'évaluer, d'interpréter et de produire rapidement un large éventail d'informations. Ces informations, y compris celles issues de la surveillance basée sur les événements (EBS), permettent d'appréhender la situation et de communiquer de manière à prendre des décisions éclairées (2). On peut améliorer la veille sanitaire pendant les rassemblements de masse en utilisant une combinaison de systèmes existants de surveillance basée sur des indicateurs (IBS), tels que la surveillance des maladies à déclaration obligatoire, la surveillance syndromique, le renforcement du dépistage en laboratoire et l'EBS, qui sont complémentaires (1, 3-7). Le type de surveillance et le niveau d'amélioration requis dépendent des objectifs et du type d'informations et de données à collecter, qui sont déterminés sur la base de l'évaluation des risques associés au rassemblement de masse.

Le principal objectif de la surveillance des alertes précoces dans le contexte des rassemblements de masse est de disposer de systèmes de surveillance à la fois sensibles et suffisamment rapides pour détecter les menaces pour la santé publique et y répondre. Pour ce faire, on peut améliorer les activités de

surveillance existantes, y compris la surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ou les compléter par d'autres processus comme une EBS spécifique. L'EBS, définie comme la collecte, le suivi, l'évaluation et l'interprétation organisés d'informations principalement ponctuelles et non structurées concernant des événements sanitaires susceptibles de représenter un risque aigu pour la santé humaine, est une composante fonctionnelle du système EWAR (8).

Il existe quatre sources principales d'EBS : les communautés, les établissements de santé, les permanences téléphoniques/centres d'appels et les sources ouvertes telles que les médias ou Internet. Les signaux multisectoriels de l'EBS couvrant tous les risques peuvent être captés par les centres de santé communautaires, les structures de santé animale, les services de quarantaine, les guérisseuses et guérisseurs traditionnels, les hôpitaux, les laboratoires, les pharmacies, les cliniques vétérinaires, les centres de traitement des eaux, les permanences téléphoniques ou les centres d'appels et les sources ouvertes. Ce guide se concentre spécifiquement sur l'EBS utilisant des sources ouvertes dans le contexte des rassemblements de masse ; ce type de surveillance peut permettre de détecter les menaces pour la santé publique en adoptant une approche couvrant l'ensemble des risques dans les pays, territoires ou zones hôtes ; les lieux d'origine des participant(e)s ; et les pays voisins. Elle peut intégrer un éventail de sources formelles et informelles, y compris les médias d'information, des rapports ponctuels ou réguliers publiés par des organismes internationaux et locaux tels que les agences des Nations Unies et les autorités nationales et infranationales. Elle peut également exploiter des rumeurs ou des rapports d'événements de santé publique inhabituels dans le contexte d'un rassemblement de masse émanant d'informatrices et d'informateurs clés sur le terrain, notamment le personnel de surveillance, les participant(e)s à l'événement et les agent(e)s de santé. Dans l'idéal, les renseignements recueillis grâce à l'EBS sont évalués de manière intégrée avec les informations provenant d'autres systèmes de surveillance. Les données doivent être diffusées aux parties prenantes concernées au sein du secteur de la santé et au-delà, y compris aux organisateurs de l'événement, afin d'orienter la prise de décisions et de promouvoir une surveillance collaborative (9).

Bien l'OMS ait publié des guides sur l'EBS, il n'en existe pas de spécifique pour la planification et la réalisation de l'EBS dans le contexte des rassemblements de masse (8, 10). Ce guide pratique décrit les étapes nécessaires à la mise en œuvre de l'EBS utilisant des sources ouvertes dans le cadre des rassemblements de masse, ainsi que des études de cas de pays ayant fait l'expérience de rassemblements de masse, en se concentrant principalement sur les éléments utiles aux référents et référents nationaux pour la surveillance.

Méthodologie

.....

Ce guide a été élaboré à partir d'une revue de la littérature et de consultations avec les unités compétentes de l'OMS dans le cadre du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, ainsi qu'avec des spécialistes en matière de rassemblements de masse ou de veille sanitaire.

Les publications sélectionnées pour la revue portaient sur la surveillance elle-même ou sur la surveillance lors de précédents rassemblements de masse. Plus précisément, ces publications ont été extraites de PubMed en utilisant les termes de recherche suivants : surveillance, surveillance basée sur les événements, veille sanitaire, veille épidémique, surveillance collaborative, alerte précoce et riposte, rassemblement de masse, Jeux olympiques, Coupe du monde, événement sportif, pèlerin et urgence sanitaire. Certains termes de recherche ont été combinés pour optimiser les résultats. Les publications examinées et retenues ont été rédigées ou publiées par des autorités sanitaires nationales ou locales, des organisateurs d'événements et l'OMS. D'autres documents pertinents de l'OMS et des rapports sur de précédents rassemblements de masse ont également été examinés afin d'harmoniser le contenu.

Le projet de document a été principalement rédigé par l'unité Santé aux frontières et rassemblements de masse au Siège de l'OMS. Il a été revu à plusieurs reprises par diverses unités et par les bureaux de l'OMS. Des spécialistes externes en matière de rassemblements de masse ou de veille sanitaire, y compris des centres collaborateurs de l'OMS, l'ont ensuite examiné afin de s'assurer que son contenu concorde avec les publications de l'OMS et les lignes directrices et pratiques mondiales et locales.

Les exemples de pays figurant à la fin de ce document ont été tirés des publications extraites selon la méthode susmentionnée. Ces pays ont été sélectionnés parmi ceux qui ont accueilli (jusqu'en 2024) des rassemblements de masse internationaux, pour lesquels des activités de surveillance étaient documentées. Étant donné que le type de rassemblement peut influencer sur l'évaluation des risques et les objectifs de surveillance, les exemples ont été choisis de manière à inclure à la fois des événements sportifs et religieux.

Guide étape par étape pour adapter l'EBS utilisant des sources ouvertes aux rassemblements de masse

Avant de planifier l'adaptation de l'EBS utilisant des sources ouvertes aux rassemblements de masse

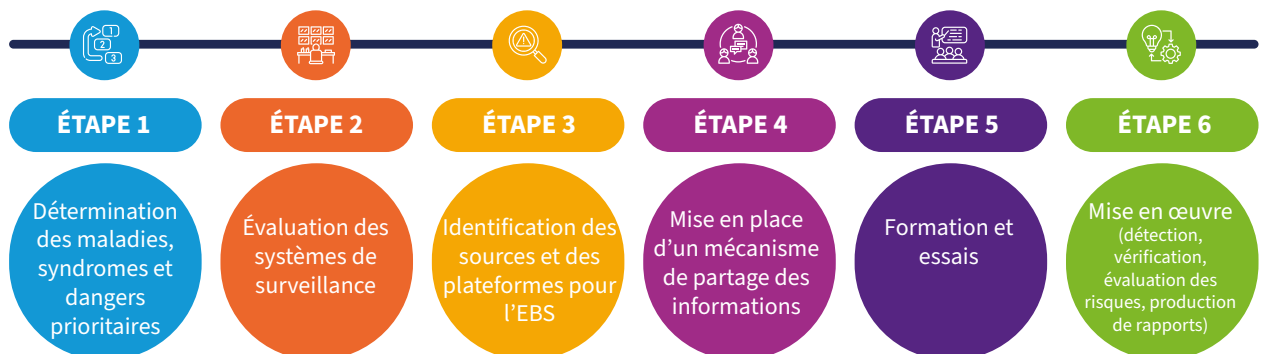
Avant de planifier l'adaptation de l'EBS utilisant des sources ouvertes à un rassemblement de masse, il est essentiel de comprendre les risques globaux associés à l'événement prévu. [L'outil de l'OMS pour évaluer l'ensemble des risques lors de rassemblements de masse](#) donne des indications sur les éléments à prendre en compte dans le contexte de tels événements, comme l'ampleur du rassemblement, y compris le nombre prévu de participant(e)s, la durée de l'événement et la présence ou non de participantes et participants internationaux, ainsi que d'autres facteurs spécifiques à l'événement. Sur la base de ces informations, l'outil fournit également une approche systématique fondée sur des données probantes pour identifier et classer les risques associés ; une description du niveau de préparation et de capacité d'intervention à l'échelle nationale ; des orientations sur la mise en œuvre d'une évaluation complète et stratégique des risques pour mieux élaborer les plans de préparation et de riposte

avant le rassemblement de masse ; et une évaluation estimée de la capacité du pays hôte à identifier les effets négatifs potentiels sur la santé et à y répondre (11, 12). L'évaluation de l'ensemble des risques¹ fournit des informations qui aident à déterminer les objectifs de surveillance. L'évaluation des risques doit être adaptée, répétée à intervalles réguliers et maintenue tout au long du cycle de l'événement (planification, mise en œuvre, clôture) afin d'assurer une évaluation continue des risques et d'adapter les mesures en conséquence (11, 12).

Étapes pour adapter l'EBS aux rassemblements de masse

La mise en œuvre de l'EBS pour les rassemblements de masse comporte six étapes principales (Figure 1). Ce processus peut se recouper avec les activités de veille sanitaire, mais il faut garder à l'esprit des considérations spécifiques pour améliorer l'EBS dans le cadre des rassemblements de masse. Cette section développe ces considérations.

Figure 1: Six étapes pour améliorer la surveillance basée sur les événements (EBS) utilisant des sources ouvertes pour les rassemblements de masse



¹ L'évaluation de l'ensemble des risques est un concept qui considère que, si les sources de risques sont variées (naturelles, technologiques, sociétales), elles mettent souvent les systèmes de santé à l'épreuve d'une manière similaire. Ainsi, l'atténuation des risques, la préparation aux situations d'urgence, les mesures d'intervention et les activités de relèvement communautaire sont généralement mises en œuvre selon le même modèle, quelle que soit la cause (<https://www.who.int/europe/emergencies/our-work-in-emergencies/key-approaches>).

Étape 1 : Détermination des maladies, syndromes et dangers prioritaires

Du fait que les rassemblements de masse concernent des zones géographiques étendues et que les médias s'y intéressent, il se peut que la référente ou le référent pour la surveillance détecte plus de signaux que d'ordinaire, ce qui nécessite de faire des vérifications supplémentaires, de réaliser une évaluation des risques et de produire des rapports.² La liste de signaux doit être aussi sensible que possible et, lors d'un rassemblement de masse, il peut être justifié de déterminer au préalable les dangers prioritaires pour la santé publique afin de définir la spécificité globale de cette liste de signaux (11). Ces maladies, syndromes ou dangers prioritaires peuvent également faire l'objet d'autres activités de surveillance pendant les rassemblements de masse, comme les systèmes de surveillance systématique améliorés des maladies à déclaration obligatoire, la surveillance sentinelle, la surveillance syndromique et la surveillance en laboratoire. Dans l'idéal, l'établissement des priorités devrait tenir compte des dangers, des menaces spécifiques, de l'évaluation des risques spécifiques au rassemblement de masse et au pays, et doit intervenir bien avant l'événement prévu. Bien qu'il n'y ait pas de calendrier standard pour lancer ce processus, car il dépend de l'ampleur de l'événement, certains pays ayant accueilli des rassemblements de masse internationaux par le passé ont entamé ce processus des années à l'avance (13, 14). À moins que le rassemblement ne survienne de manière inattendue, en fonction de l'ampleur de l'événement et des complexités attendues, cette étape devrait commencer au moins quelques mois à l'avance. Lors de l'établissement des priorités, il convient d'examiner les points suivants.

1. Maladies comportant un risque d'importation et de propagation dans la population générale des pays hôtes

Les maladies infectieuses endémiques dans les pays et les zones où des participant(e)s sont attendus en nombre peuvent être considérées comme prioritaires. Parmi ces maladies, il convient d'accorder une attention particulière à celles qui sont susceptibles de se propager largement dans la population générale et d'avoir de graves conséquences. Il s'agit, par exemple, de maladies à transmission interhumaine, très infectieuses et peu prévalentes dans la population générale. Les maladies touchant certaines tranches d'âge dans la communauté hôte et la présence de vecteurs doivent également être prises en compte. De plus, la priorité doit être accordée aux maladies infectieuses qui pourraient se propager rapidement dans les milieux surpeuplés, comme la rougeole, l'infection à méningocoque et les infections respiratoires. La saisonnalité des maladies et la

situation géographique des pays et zones hôtes et des participant(e)s peuvent également être des facteurs à prendre en compte. Par exemple, une maladie infectieuse peu fréquente dans l'hémisphère Sud pendant l'été, comme la grippe saisonnière, peut être introduite par des participant(e)s de l'hémisphère Nord et vice versa. Dans le cas de maladies dont la période d'incubation est relativement longue, qui ne peuvent pas être détectées immédiatement par les activités d'EBs dans le cadre des rassemblements de masse, la surveillance doit être menée dans les pays et les zones d'où l'on attend un grand nombre de participant(e)s. La surveillance doit commencer bien avant le rassemblement de masse et se poursuivre pendant la durée de l'événement afin de prévenir et de détecter de futures flambées épidémiques dues à l'importation associée au rassemblement de masse dans les pays et les zones hôtes. Ces maladies peuvent être identifiées sur la base d'analyses documentaires et d'informations sur les épidémies passées, ainsi que sur des estimations de la charge de morbidité dans les pays et les zones d'où l'on attend de nombreux participant(e)s.

2. Maladies épidémiques ou pandémique

Dans le passé, certains rassemblements de masse ont coïncidé avec une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l'OMS. C'est le cas, par exemple, des trois grands événements sportifs organisés en Afrique en 2014 et 2015 pendant l'épidémie de maladie à virus Ebola, des Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 pendant l'épidémie de maladie à virus Zika, des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022 et de la Coupe du monde de football du Qatar 2022 pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que des rassemblements de masse internationaux pendant la recrudescence de la variole (6, 15-19). En fonction de la situation épidémiologique pendant les rassemblements de masse, il convient d'accorder une attention particulière au potentiel de propagation dans les pays et les zones où la circulation de ces maladies est faible ou inexistante, ainsi qu'au risque de variants nouvellement identifiés dont la virulence est inconnue. Il est important de noter que les capacités de détection peuvent varier d'un pays à l'autre et que ce qui est détecté dans les pays et les zones hôtes peut ne pas l'être aussi rapidement dans les pays d'origine des participant(e)s, et vice versa. En plus des informations sur les maladies humaines, les données sur les maladies non humaines, telles que celles issues d'enquêtes sur la santé animale ou l'environnement peuvent fournir des indications pour évaluer le risque de flambées épidémiques humaines à l'avenir.

2 L'OMS a mis au point une approche mondiale de la veille sanitaire qui comprend la détection, la vérification, l'évaluation des risques et la production de rapports sur les menaces aiguës pour la santé publique. Des informations détaillées sont disponibles à l'adresse <https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0002359>.

Ces maladies peuvent être classées dans la section 1 ci-dessus (Maladies comportant un risque d'importation et de propagation dans la population générale des pays hôtes). Souvent, toutefois, les maladies épidémiques ou pandémiques n'apparaissent pas pendant la phase de planification de la surveillance du rassemblement de masse, qui doit commencer bien avant l'événement. Une mise à jour de dernière minute de l'évaluation des risques et des mesures d'atténuation peut donc s'avérer nécessaire, de même qu'une redéfinition des priorités concernant les maladies et les syndromes.

3. Maladies comportant un risque d'exportation vers les pays et les zones d'origine des participant(e)s

Les maladies infectieuses très répandues dans les pays et les zones hôtes peuvent également être surveillées afin de déterminer le risque d'exportation vers les pays d'origine des participant(e)s. Les activités d'EBS à mener après le rassemblement de masse doivent couvrir à la fois les signaux nationaux et les signaux internationaux, en tenant compte de la période d'incubation des maladies prioritaires et de la durée prévue du séjour des participant(e)s après l'événement.

4. Maladies peu connues des cliniciennes et cliniciens dans les pays hôtes

Il est important de prendre en compte les maladies infectieuses répandues dans les pays d'origine des participant(e)s, mais peu connues des cliniciennes et cliniciens dans les pays où les rassemblements de masse ont lieu. La méconnaissance de ces maladies peut entraîner des erreurs de diagnostic ou des retards dans l'établissement du diagnostic et la notification, car elles peuvent ne pas être envisagées initialement et n'être prises en compte qu'à un stade ultérieur dans le cadre du diagnostic différentiel. De plus, ces maladies peuvent nécessiter des produits de diagnostic de laboratoire spécifiques qui ne sont disponibles que dans un nombre limité de structures, ce qui pourrait retarder la détection et accroître le risque d'exposition des personnes sensibles. Ces maladies peuvent être identifiées en consultant les cliniciennes et cliniciens et les laboratoires dans le pays hôte et en recueillant des informations épidémiologiques sur les maladies qui revêtent une importance au niveau mondial. Les pays ou les zones d'où l'on attend des participant(e)s en nombre pourraient s'impliquer dans cette consultation. L'EBS peut jouer un rôle en signalant la possibilité d'importation de ces maladies, en particulier celles qui figurent sur la liste des maladies prioritaires.

5. Maladies non diagnostiquées

Des événements de santé publique de causes inconnues sont susceptibles d'être détectés

lors de rassemblements de masse grâce à la combinaison de la surveillance syndromique et de l'EBS. L'EBS utilisant des sources ouvertes pour les rassemblements de masse peut être adaptée en utilisant une combinaison appropriée de symptômes et de mots-clés si un tel système n'est pas déjà en place.

Dans le même temps, il convient d'utiliser également des mots-clés spécifiques tels que « maladie mystérieuse » ou « maladie inconnue », compte tenu du fait que certaines maladies ou certains dangers sans caractéristiques syndromiques spécifiques peuvent être détectés.

6. Menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

Au-delà des maladies infectieuses, le système de surveillance doit être suffisamment adaptable pour détecter d'autres menaces pour la santé publique. Sur la base d'une évaluation de l'ensemble des risques, il est souhaitable d'adapter l'EBS utilisant des sources ouvertes pour les rassemblements de masse de manière à pouvoir détecter les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), si cette capacité n'est pas déjà en place (11, 12). Une menace CBRN peut prendre la forme d'un accident, mais il convient de garder à l'esprit la possibilité d'une attaque terroriste, étant donné que les rassemblements de masse ont parfois été utilisés comme plateformes pour des actions nuisibles délibérées. Les signaux, les indicateurs et les sources de l'EBS doivent être identifiés au préalable en collaboration avec les parties prenantes nationales et internationales.

7. Incidents environnementaux et incidents survenant pendant l'événement

Dans le contexte des rassemblements de masse, il faut tenir compte d'autres situations potentielles, telles qu'un nombre élevé de victimes et des traumatismes graves dus à des mouvements de foule, des maladies non transmissibles associées à des conditions météorologiques et à des activités extrêmes, des incidents associés à une consommation accrue d'alcool et de drogues, des problèmes de sécurité sanitaire des aliments potentiellement liés à l'événement et des catastrophes naturelles. En fonction du contexte de l'événement, on peut aussi envisager des problèmes psychologiques, comme les phénomènes psychogéniques de masse.

Il convient de noter que certaines maladies et certains dangers peuvent être pertinents ou applicables à plusieurs de ces facteurs. Une fois que les maladies et les dangers prioritaires ont été identifiés, il faut envisager de les réaffirmer en effectuant une évaluation des risques pour chaque maladie et chaque danger, en mettant l'accent sur le risque d'importation, sa probabilité, sa gravité potentielle et la perception qu'en a le public.

Étape 2 : Évaluation de l'EBS existante utilisant des sources ouvertes

Il est souhaitable d'établir le système de surveillance des rassemblements de masse sur la base du système existant. Par conséquent, il est essentiel de comprendre l'EBS existante dans le pays ou la zone où se déroule l'événement. En général, le Règlement sanitaire international (RSI) (2005), l'outil d'autoévaluation pour l'établissement de rapports annuels par les États Parties (SPAR) et l'outil d'évaluation extérieure conjointe (JEE) peuvent fournir une vue d'ensemble de l'état de préparation et de la fonctionnalité dans l'ensemble du pays ou de la zone (20, 21). Dans le contexte des rassemblements de masse, il est important de déterminer si ces systèmes sont suffisants pour détecter les signaux de santé publique se produisant sur le site et aux alentours, ainsi que dans la population générale des pays ou des zones hôtes. Les signaux de santé publique doivent pouvoir être évalués dans les pays d'origine des participant(e)s, ainsi que dans les pays voisins, en particulier compte tenu de la mobilité internationale à grande échelle de la population qui accompagne souvent les rassemblements de masse. Cette évaluation doit être effectuée bien avant la tenue de l'événement. Au cours de cette période, il convient de réfléchir à la façon dont l'ajustement appliqué à l'EBS pour le rassemblement de masse peut être intégré au système de routine après l'événement ou pour les futurs rassemblements de masse.

1. Évaluation de l'EBS existante utilisant des sources ouvertes

1.1 Champ d'application

1.1.1. Couverture géographique

Évaluer si l'EBS existante utilisant des sources ouvertes porte seulement sur la détection des signaux nationaux ou si elle englobe également les signaux internationaux et régionaux. Si elle se concentre uniquement sur les signaux nationaux, envisager de l'étendre aux signaux liés aux pays ou aux zones d'origine des participant(e)s et aux zones voisines si des participant(e)s sont attendus en nombre. Si les pays ou les zones hôtes sont situés dans des endroits où l'on anticipe une mobilité légale ou illégale de la population, les signaux provenant de ces lieux doivent également être pris en compte. Si les pays ou les zones hôtes ont des partenaires techniques externes qui couvrent des secteurs géographiques plus larges pour l'EBS, envisager de communiquer avec eux pour assurer la coordination.

1.1.2. Couverture des dangers

Évaluer si l'EBS existante utilisant des sources ouvertes détecte de manière adéquate l'importation et l'exportation potentielles des dangers et des risques considérés, classés par ordre de priorité sur la base de l'évaluation des risques avant et pendant l'événement. Si ce n'est pas le cas, des ajustements peuvent être envisagés. Le suivi des événements de santé publique internationaux, tels que des flambées épidémiques de maladies infectieuses dans les pays et les zones où les participant(e)s peuvent séjourner ou résider avant de se rendre au rassemblement de masse, peut également fournir des indications précieuses pour hiérarchiser les activités de détection et de riposte.

1.1.3. Fréquence

Évaluer si la fréquence de la surveillance, de l'enregistrement et de la notification est suffisante pour collecter des informations de santé publique pertinentes et les diffuser auprès des parties prenantes concernées dans les délais prévus. Si la fréquence actuelle est insuffisante, envisager de l'augmenter si les ressources nécessaires sont disponibles. L'EBS pour le rassemblement de masse doit couvrir les signaux 24 heures sur 24, avant, pendant et après l'événement.

2. Système/plateforme

2.1 Système/plateforme de détection

Évaluer l'adaptabilité de la plateforme de suivi des sources ouvertes utilisée pour l'EBS existante afin de déterminer si elle convient également aux rassemblements de masse. S'il n'est pas possible de l'adapter pour étendre le nombre de pays, de maladies et d'affections, et de sources d'information, il convient d'envisager d'autres plateformes ou des plateformes complémentaires. En outre, il faut évaluer si le système actuel de gestion des événements et des urgences permet de détecter efficacement et en temps utile les flambées épidémiques locales et d'autres risques sanitaires.

Certaines plateformes existantes peuvent être dotées de fonctionnalités avancées, telles que l'envoi d'alertes automatisées pour vérification sur la base de seuils prédéfinis. Ces dispositifs sont intéressants pour l'EBS pendant des rassemblements de masse et pourraient être adaptés aux besoins liés à ce type d'événement.

2.2 Mécanisme de diffusion de l'information

S'assurer que les informations ou les signaux détectés par l'EBS sont partagés avec toutes les parties prenantes internes et externes qui ont besoin d'un accès régulier ou immédiat à l'information et qui sont impliquées dans la riposte pendant le rassemblement de masse. Il peut s'agir d'autorités sanitaires locales ou nationales, des organisateurs de l'événement ou de partenaires extérieurs.

2.3 Capacités

Évaluer les ressources humaines, financières et techniques disponibles. Si l'EBS adaptée à l'événement est susceptible de nécessiter des ressources supplémentaires, il convient de préciser les ressources nécessaires et de déterminer comment les obtenir pour assurer une surveillance efficace. Si les ressources requises dépassent celles qui peuvent être mobilisées facilement, envisager de former des partenariats avec d'autres organisations ou organismes déjà engagés dans des activités de surveillance ou de suivi d'événements similaires. La collaboration avec des partenaires extérieurs peut aider à combler les lacunes en matière de ressources en partageant les coûts, le personnel et l'infrastructure technologique.

2.4 Pays dans lesquels les activités d'EBS utilisant des sources ouvertes sont limitées ou inexistantes

Dans les pays où les activités d'EBS utilisant des sources ouvertes ne constituent peut-être pas une activité de surveillance majeure – en raison d'un faible nombre d'articles de presse ou de publications, ou pour d'autres raisons opérationnelles –, il convient d'envisager d'introduire l'EBS si cela en vaut la peine. Par exemple, si un rassemblement de masse implique plusieurs pays et que l'on anticipe des mouvements transfrontaliers entraînant un plus grand nombre d'articles, l'EBS pourrait être envisagée. Les résultats de l'EBS peuvent venir compléter la surveillance existante qui se concentre principalement sur les signaux de santé publique nationaux.

Étape 3 : Identification des sources d'information et des plateformes pour la surveillance

De multiples sources et plateformes sont disponibles pour appuyer l'EBS utilisant des sources ouvertes. Elles sont souvent utilisées en combinaison et peuvent être adaptées pour la surveillance des rassemblements de masse. La combinaison peut être modifiée en fonction des objectifs et des ressources disponibles.

1. Sources d'information pour l'EBS

Il existe plusieurs sources d'information pour l'EBS utilisant des sources ouvertes. Les principales sources pour surveiller l'importation et l'exportation potentielles de maladies, les syndromes et les dangers associés aux rassemblements de masse sont les articles de presse, les sites Web officiels, les publications, les médias sociaux et toute autre source sur Internet. En plus des contenus clairement liés à l'événement prévu, il est utile de collecter des informations accessibles au public sur les événements susceptibles de présenter un risque pour le rassemblement de masse, tels qu'un événement délibérément provoqué survenu à proximité des sites où se déroulera le rassemblement de masse, ou le premier cas autochtone d'une maladie à transmission vectorielle susceptible de se propager. Les référent(e)s pour la surveillance dans les pays peuvent également utiliser les informations de l'OMS, notamment les bulletins d'information sur les flambées épidémiques et le tableau de bord des urgences sanitaires, qui sont accessibles au public, et le site d'information sur les événements, qui n'est accessible qu'aux points focaux nationaux RSI (22, 23).

2.1 Plateformes pour l'EBS

Pour suivre les informations provenant de sources ouvertes, les autorités sanitaires nationales peuvent créer de nouvelles plateformes ou se connecter à celles qui existent déjà en amont du rassemblement de masse et surveiller systématiquement ces plateformes tout au long du rassemblement de masse – avant, pendant et après l'événement. Différentes plateformes sont disponibles à cet effet, notamment la plateforme EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources) de l'OMS.

2.2 Plateforme existante

Une plateforme nationale bien établie pour la surveillance des sources ouvertes peut être utilisée pour élargir l'attention à des maladies, syndromes ou dangers prédéterminés pertinents pour le rassemblement de masse prévu et augmenter la fréquence des activités d'EBS (10) (Tableau 1). Il s'agit de l'option la plus simple, bien qu'elle

Tableau 1 : Exemples d'outils EWAR (signalement précoce, alerte et riposte) entièrement électroniques (en mars 2022)

Outil	Entité responsable du logiciel	Système EWAR complet	Détection des flambées épidémiques	Recherche et suivi des contacts	Exemples d'utilisation
EWARS-in-a-box	OMS	✓	✓		Cox's Bazar, Libéria, nord du Nigéria, Soudan du Sud
Electronic Disease Early Warning System (eDEWS)	Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	✓	✓		Libéria, Pakistan, Somalie, Yémen
District Health Information Software version 2 (DHIS2)	Université d'Oslo	✓	✓	✓	Ouganda, Rwanda, République-Unie de Tanzanie
Go.Data	OMS	✓	✓	✓	65 pays et >115 institutions, y compris : Afrique du Sud (Province de l'État libre), Argentine, Bangladesh, Gabon, Guatemala, Malte, Ouganda, Suisse (canton de Vaud), Ukraine. Plus de détails sont disponibles dans le rapport annuel Go.Data
Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System (SORMAS®)	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)	✓	✓	✓	Ghana, nord du Nigéria

puisse nécessiter davantage de temps pour la recherche et la vérification des signaux, ainsi que des ressources humaines supplémentaires en fonction de la plateforme. Bien qu'une plateforme supplémentaire puisse être envisagée en fonction des objectifs et des besoins, les informations provenant des multiples plateformes doivent être bien intégrées, soit au niveau du système, soit pendant la phase de mise en commun des informations, afin de rationaliser l'évaluation des risques.

2.2. Système EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources)

EIOS est une initiative clé qui fournit des informations de sources ouvertes pour la prise de décisions en matière de santé publique. Ce système est géré par l'OMS et est utilisé quotidiennement par les gouvernements et les organisations du monde entier. Le système EIOS utilise une technologie de pointe pour exploiter la puissance des données de sources ouvertes aux fins de la

détection et de l'évaluation des menaces pour la santé publique en temps quasi réel. Il s'agit d'un système basé sur le Web adapté à l'objectif, conçu pour accroître et accélérer les activités mondiales de veille sanitaire, fruit d'une collaboration entre l'OMS et le Centre commun de recherche de la Commission européenne (24).

Le système recueille en temps quasi réel des articles de presse, des résumés et des rapports provenant d'entités internationales telles que le Programme de surveillance des maladies émergentes (ProMED), le Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP), HealthMap et l'Europe Media Monitor (EMM) (25-28) (Figure 2). L'élaboration d'un tableau EIOS adapté aux rassemblements de masse peut être envisagée, en incorporant des catégories³ pour filtrer efficacement et afficher des signaux, maladies, syndromes ou dangers prioritaires prédéterminés. Les catégories peuvent inclure non seulement des noms de maladies spécifiques, mais aussi des symptômes ou des combinaisons de

3 Dans le contexte de l'EBS et du système EIOS, une catégorie est une menace, un risque ou un danger pour la santé publique. Le système EIOS détecte et classe les articles par maladies ou agents pathogènes spécifiques, catastrophes naturelles, crises humanitaires, incidents liés à l'alimentation, rassemblements de masse, mesures de prévention, sécurité des produits, etc.

symptômes pour faciliter la détection des maladies idiopathiques. Des catégories nouvellement créées, qui ne figuraient pas à l'origine dans le système, mais qui ont été explicitement adaptées aux menaces CBRN, telles que « poudre blanche », peuvent également être intégrées afin de faciliter l'identification des menaces terroristes associées aux rassemblements de masse. En outre, les utilisatrices et utilisateurs peuvent sélectionner des pays et des zones d'intérêt prédéterminés, ce qui permet une surveillance transnationale sur un seul tableau. Les articles affichés peuvent être filtrés en fonction de la période, de la langue, des entités mentionnées, de la maladie ou du type de syndrome, y compris les maladies et les sources « inconnues ». Des zones géographiques et des organisations spécifiques peuvent également être incluses pour recueillir des informations sur les sites concernés par le rassemblement de masse.

Le système EIOS est utilisé à la fois par les autorités nationales et les organisations internationales comme plateforme complémentaire ou comme alternative aux systèmes nationaux existants pour surveiller les articles de presse et les informations provenant d'agrégateurs de sources ouvertes lors de précédents rassemblements de masse à l'échelle mondiale, afin de servir des objectifs et des priorités spécifiques (29-31). C'est l'un des principaux systèmes de surveillance des médias et il fournit des informations épidémiologiques mondiales cohérentes et en temps utile (29).

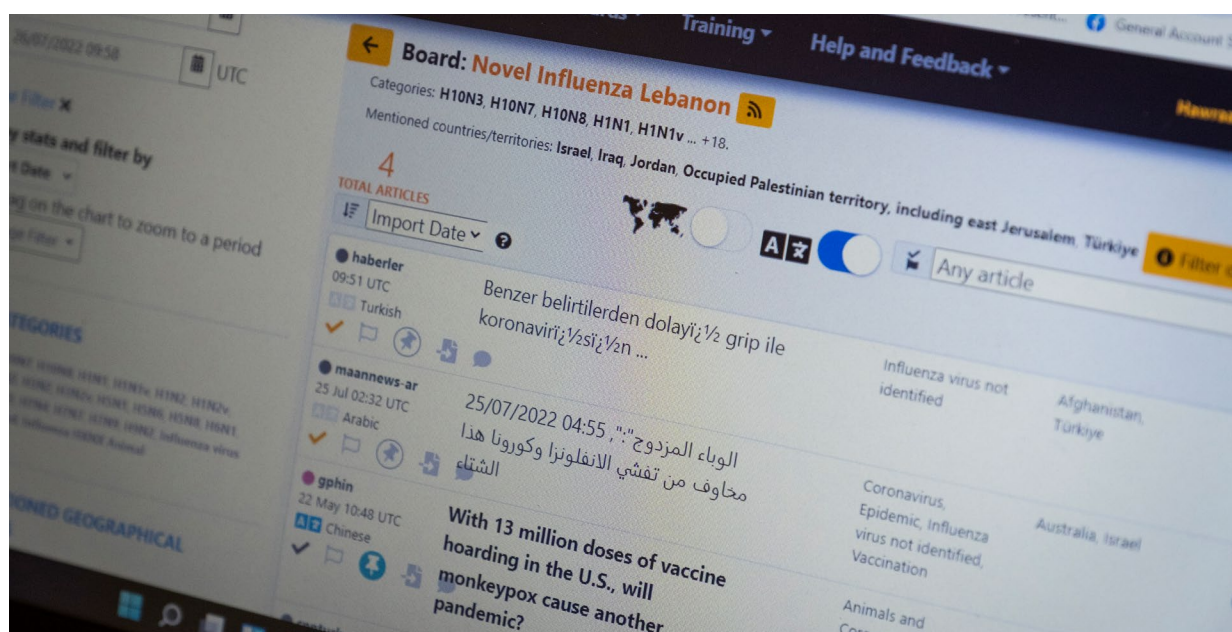
Pour obtenir l'accès au système EIOS, il faut prendre contact avec le point focal EIOS du bureau

régional de l'OMS concerné ou avec l'équipe de base de l'initiative EIOS à eios@who.int. Une fois que l'accès leur a été accordé, les utilisatrices et utilisateurs peuvent modifier eux-mêmes le tableau en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs, sans l'intervention de l'OMS, sauf si cela est jugé nécessaire. Lorsque l'outil est introduit dans un nouveau pays ou une nouvelle zone géographique (32), une formation au système EIOS est dispensée et une assistance technique régulière est également disponible. Il existe également une option permettant de restreindre l'accès au tableau, de sorte que seules les personnes sélectionnées puissent le consulter et que la confidentialité soit préservée. Cette fonction peut être importante pour certains utilisateurs, car les catégories sélectionnées sur les tableaux sont souvent basées sur des évaluations de risques spécifiques aux rassemblements de masse, qui peuvent être sensibles et ne devraient pas être accessibles à des personnes non autorisées.

2.3 Autres options

Il existe d'autres options, comme les plateformes développées par des institutions, des organisations ou des entreprises privées extérieures qui proposent des activités et des technologies de veille sanitaire en fonction des besoins du pays hôte. Les plateformes internationales de partage d'informations bien établies peuvent également être considérées comme des ressources supplémentaires.

Figure 2 : Exemple de surveillance au Liban, juillet 2022



Le personnel du ministère de la Santé publique à Beyrouth, au Liban, se réunit et examine les articles de presse sur la grippe et d'autres événements liés aux virus respiratoires le 26 juillet 2022, dans le cadre de la surveillance de routine. La surveillance de routine des virus respiratoires repose sur l'analyse d'échantillons prélevés auprès de patients symptomatiques consultant dans des établissements de santé pour la grippe, le SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires. Les informations issues de cette surveillance de routine sont essentielles pour orienter les actions nationales, régionales et mondiales en matière de préparation et de réponse aux maladies virales respiratoires.

Crédit : OMS/Natalie Naccache

Remarque : Les informations issues de cette surveillance sont importantes pour guider les actions à mener aux niveaux national, régional et mondial pour se préparer et répondre aux maladies et aux dangers.

Étape 4 : Mise en place ou renforcement du mécanisme de partage des informations

Un mécanisme de partage des informations solide et bien défini est l'un des éléments essentiels des activités quotidiennes de veille sanitaire pour les rassemblements de masse qui permettent une réaction immédiate. Bien qu'il existe peut-être déjà un mécanisme en place pour les activités habituelles d'EBS, il est crucial de disposer d'un mécanisme bien structuré spécifique aux rassemblements de masse pour communiquer avec les personnes décisionnaires et l'ensemble des partenaires ou des parties intéressées afin de garantir la cohérence des messages.

1. Identifier les destinataires des informations

Dans le cadre des activités de préparation, il est essentiel de commencer par identifier les partenaires ou les parties intéressées participant à la mise en commun des informations avant le rassemblement de masse. Les parties intéressées peuvent être les autorités nationales et locales, les organisateurs de l'événement, d'autres organes gouvernementaux (Ministère de l'intérieur, Ministère du tourisme, Ministère des sports, etc.), les organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité, ainsi que des organisations et groupes communautaires ou religieux, entre autres.

Si cela s'avère nécessaire et approprié, les autorités des régions et des pays voisins peuvent être impliquées. L'inclusion de partenaires techniques internationaux et d'autres parties prenantes peut également être envisagée en fonction de leur relation et de leur implication dans les activités de surveillance et d'intervention. Une concertation au sein des pays et zones accueillant le rassemblement de masse, ainsi qu'avec les entités et les pays concernés, peut être nécessaire pour identifier les avantages mutuels et discuter des mécanismes de partage des informations.

2. Identifier le mécanisme de partage des informations

2.1 Mécanisme ordinaire de partage des informations

Les informations collectées pour les rassemblements de masse doivent être régulièrement communiquées aux partenaires concernés ou aux parties intéressées sous la forme de rapports quotidiens internes et externes avec une liste de distribution bien définie. En fonction de la plateforme utilisée, le partage d'informations peut se faire entre les personnes auxquelles l'accès a été accordé. La liste des destinataires des rapports peut varier en fonction de l'événement. Dans l'idéal, ces rapports intègrent les informations de l'EBS avec les données et les résultats d'autres systèmes de surveillance, tels que la surveillance basée sur les indicateurs (IBS), la surveillance syndromique, la surveillance sentinelle et la surveillance en laboratoire. Le temps pendant lequel la diffusion des informations est nécessaire peut dépendre de la durée de mise en œuvre

du système de surveillance avant, pendant et après l'événement. Les mécanismes ordinaires de partage des informations peuvent également inclure le partage d'informations avec les parties prenantes internationales lorsque la détection des signaux de santé publique est effectuée au niveau international. Les résultats de ces activités de surveillance peuvent être intégrés dans une évaluation des risques au niveau national.

2.2 Partage d'informations par le biais du RSI

Un événement de santé publique national inhabituel ou inattendu qui peut avoir de graves conséquences pour la santé publique et qui figure parmi les événements énumérés à l'annexe 2 du RSI (2005) doit être notifié à l'OMS par l'intermédiaire du mécanisme RSI. Il en va de même pour les événements de santé publique internationaux, y compris ceux dont la cause est inconnue, ou pour les maladies qui peuvent avoir de graves répercussions sur la santé publique et se propager rapidement à l'échelle internationale (33). Dans le cas d'événements ne nécessitant pas de notification telle que prévue à l'article 6 du RSI, en particulier les événements pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour mener à bien l'évaluation prévue à l'annexe 2 du RSI, les pays et les zones peuvent informer l'OMS par l'intermédiaire du point focal national RSI et consulter l'OMS à propos des mesures sanitaires à prendre. Le partage d'informations entre pays ou entre régions peut être envisagé si nécessaire, par l'intermédiaire du point focal national RSI.

2.3 Mécanisme de partage d'informations multipartenaires pour les situations d'urgence

Si le signal de santé publique détecté exige une action rapide de la part des parties prenantes, il faut envisager une communication multisectorielle immédiate par le biais d'un canal convenu à l'avance, sans attendre la publication du prochain rapport de situation. Il convient de s'assurer qu'un mécanisme de partage des informations en cas d'urgence est en place. Il peut s'agir de mettre en place un système de gestion des incidents au sein d'un centre d'opérations d'urgence (Figure 3) avec des modes opératoires normalisés clairs, si ceux-ci ne sont pas déjà établis (34, 35), et une liste de distribution appropriée. Le système de gestion des incidents facilitera la communication et permettra d'accélérer la notification et les interventions. Il facilitera également la coordination des efforts sanitaires en intégrant les informations opérationnelles et contextuelles provenant de différentes entités telles que les secteurs de la santé, de la sécurité et animalier ou les autorités locales, selon les besoins, en optimisant la communication entre eux. Les informations peuvent être partagées par le biais de rapports de situation publiés régulièrement ou de manière ponctuelle en réponse à des cas particuliers ou à des demandes de renseignements. Il convient également d'envisager la création d'un groupe de travail réunissant tous les partenaires afin de faciliter la communication avec les partenaires internationaux.

Figure 3. COVID-19 : Éthiopie, février 2020. L'entrée d'un centre d'opérations d'urgence prêt à faire face à une éventuelle flambée de coronavirus.



L'entrée d'un Centre des opérations d'urgence pour la coordination de la préparation à la COVID-19 à Addis-Abeba, le 13 février 2020. L'Éthiopie renforce la surveillance, les capacités de diagnostic, les soins médicaux et l'information en santé publique en prévision d'une éventuelle flambée de coronavirus. Le pays constitue une importante porte d'entrée aérienne en Afrique. Sa compagnie aérienne nationale assure 34 vols par semaine vers la Chine. L'Organisation mondiale de la Santé soutient les pays du continent au cas où la transmission du virus y parviendrait. Pour en savoir plus, voir : <https://www.afro.who.int/news/ethiopia-stepping-readiness-coronavirus-disease-outbreak>

Crédit: OMS / Otto Bakano

Étape 5 : Établissement de modes opératoires normalisés, formation et essais

1. Établissement de modes opératoires normalisés

Avant de commencer la formation, il faut s'assurer qu'il existe un document, comme des modes opératoires normalisés, qui définit l'EBS utilisant des sources ouvertes spécifique au rassemblement de masse, comme indiqué dans les étapes précédentes. Ce document doit contenir des détails tels que le champ d'application de la surveillance, les maladies, dangers et signaux prioritaires, les sources et plateformes d'information et les mécanismes de partage des informations. Les modes opératoires normalisés doivent également inclure la durée de l'EBS. Il peut être souhaitable de mener des activités d'EBS pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant et après les rassemblements de masse, afin de détecter l'importation et l'exportation potentielles de maladies, les syndromes ou les dangers associés à l'événement et d'observer les tendances et le nombre d'éléments d'information recueillis. Bien qu'il n'y ait pas de calendrier défini pour l'EBS dans le cadre des rassemblements de masse, certains facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer la durée de la surveillance. Par exemple, la période d'incubation des maladies prioritaires peut éclairer la prise de décisions.

En outre, il faut prendre en compte la date de début du voyage et la durée du séjour prévues des participantes et participants internationaux avant et après le rassemblement de masse.

2. Formation

Il est également essentiel de déterminer qui sera responsable de la conduite des activités d'EBS et comment l'évaluation des risques associés aux signaux sera réalisée afin de pouvoir assurer une intervention rapide. Le personnel responsable doit être identifié en fonction du contexte des zones et des pays concernés. S'il y a déjà suffisamment de personnes qui mènent des activités d'EBS utilisant des sources ouvertes, ces personnes peuvent être formées à l'EBS spécifique aux rassemblements de masse. Dans le cas contraire, du personnel supplémentaire peut être identifié parmi les personnes ayant une expérience antérieure en matière de surveillance. Il est essentiel de s'assurer de disposer de ressources humaines suffisantes pour la mise en œuvre des activités d'EBS.

3. Essais pilotes

La plateforme doit être testée avant le rassemblement de masse afin d'identifier les problèmes potentiels. Elle doit permettre de collecter efficacement les informations nécessaires sans submerger les utilisatrices et utilisateurs

avec des quantités excessives de données dupliquées ou non pertinentes. En outre, le partage d'informations à l'aide du mécanisme préétabli doit être testé au cours des essais pilotes. Lors de ce processus, il convient de s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent les rapports qui seront produits. Les essais de l'EBS utilisant des sources ouvertes peuvent être intégrés aux essais globaux de surveillance. Si des problèmes sont identifiés, il faut envisager de modifier la plateforme et les mécanismes de partage des informations avant de lancer l'EBS utilisant des sources ouvertes pour le rassemblement de masse. Étant donné que l'EBS proprement dite peut commencer plusieurs jours ou semaines avant les rassemblements de masse, la formation et les essais pilotes doivent être programmés avant cette date. Ce processus sera utile pour réviser la documentation, telle que les modes opératoires normalisés, afin d'assurer une approche normalisée et cohérente de l'EBS.

Étape 6 : Mise en œuvre d'une EBS adaptée à l'événement

La mise en œuvre de l'EBS utilisant des sources ouvertes doit suivre les orientations mondiales et les modes opératoires normalisés élaborés pour le rassemblement de masse, ainsi que les processus standard de veille sanitaire. Au cours de la phase de mise en œuvre, l'accent sera mis sur la détection des signaux, leur vérification, l'évaluation des risques et l'établissement de rapports (36).

Si des signaux potentiels sont détectés à partir de sources ouvertes, ils feront l'objet d'un triage suivi d'une évaluation détaillée par le personnel de surveillance pour vérifier leur véracité. Ce processus consiste à recouper les informations sur le signal avec celles provenant d'autres rapports actuels, à les comparer aux tendances des données historiques, à contextualiser la situation et à consulter des spécialistes en la matière. Dans le contexte des rassemblements de masse, les étapes de triage et de vérification peuvent nécessiter une enquête sur place, par exemple un examen des données syndromiques ou de la surveillance basée sur les indicateurs au niveau des dispensaires du site ou des établissements de santé proches du site, ou des entretiens au sein d'une communauté ou d'une zone géographique. Lors de la vérification, les signaux sont évalués par rapport à une liste de signaux prioritaires prédéfinie pour le rassemblement de masse prévu.

L'évaluation des risques peut être fondée sur la probabilité d'importation, la probabilité de propagation dans la population générale où l'événement a lieu, la gravité, la perception sociale et l'impact global sur le rassemblement de masse. Les signaux peuvent être soit écartés parce qu'ils ne constituent pas une menace pour la santé publique associée à l'événement, soit retenus pour une surveillance étroite ultérieure, soit désignés comme de véritables événements de santé publique, entraînant une riposte et la collecte d'informations supplémentaires. L'évaluation des risques pour la santé publique propres à un événement est répétée chaque fois que de nouvelles informations sur l'événement sont disponibles. Une surveillance étroite est généralement exercée pour les signaux potentiels qui sont préoccupants mais qui ne remplissent pas encore les critères pour être considérés comme des événements pertinents. Cette surveillance a lieu dans les jours qui suivent la détection initiale et peut durer jusqu'à 1 ou 2 semaines, en fonction de la maladie, du syndrome ou du danger. Les signaux évalués doivent être communiqués conformément aux mécanismes prédéterminés de partage des informations.

Exemples de pays ayant fait l'expérience de rassemblements de masse

Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020

L'EBS améliorée utilisant des sources ouvertes a été développée et réalisée par l'Institut national des maladies infectieuses (NIID) pour Tokyo 2020 (37). Les maladies, syndromes ou dangers prioritaires ont été prédéterminés en fonction de leur épidémiologie, de leur gravité et du degré de méconnaissance qu'en avaient les médecins au Japon (14). Parmi ceux-ci, des maladies, des syndromes ou des dangers nécessitant une attention particulière ont été identifiés à l'issue d'une évaluation des risques, en mettant l'accent sur leur potentiel de propagation dans la population générale.

En raison de la pression exercée sur les ressources locales par la charge de la COVID-19 supportée par l'équipe nationale de surveillance et de riposte, deux ressources extérieures ont été identifiées pour compléter l'EBS existante : l'OMS et une entreprise privée disposant d'un logiciel d'intelligence artificielle (37). Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a mis en place un conseil EIOS spécifique aux Jeux pour les maladies, les syndromes et les dangers et a mené l'EBS (29). Parallèlement, le Siège de l'OMS a prêté son concours à la détection des signaux liés à la COVID-19 (30). Ces deux activités ont commencé deux semaines avant le début des Jeux olympiques et se sont terminées deux semaines après le dernier jour des Jeux paralympiques.

Les résultats de chaque activité d'EBS ont été rassemblés au NIID et compilés dans des rapports de situation quotidiens, contenant également d'autres résultats de surveillance, pour être distribués aux organisateurs de l'événement, dont le Comité national olympique et le gouvernement métropolitain de Tokyo, et à d'autres administrations locales par l'intermédiaire du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, et transmis à l'OMS par le NIID (37).

Hajj

En Arabie saoudite, le Ministère de la santé a mis en place un système d'alerte sanitaire précoce pendant le Hajj 2019, un pèlerinage international qui a lieu chaque année (4). Le système utilisé était une combinaison de données d'EBS et de surveillance syndromique capable de détecter rapidement les menaces pour la santé publique. La liste des syndromes et événements de santé publique prioritaires a été établie à l'issue d'une consultation technique internationale organisée par l'OMS et le Ministère saoudien de la santé. Les données de surveillance syndromique ont été recueillies auprès des établissements de santé et des lignes téléphoniques d'urgence, tandis que les données d'EBS ont été collectées à partir des médias, des médias sociaux, des chiffres de l'absentéisme scolaire et des registres des ventes de médicaments sans ordonnance.

Les données des deux systèmes de surveillance ont ensuite été intégrées dans le système central de gestion des données, où l'intelligence artificielle a été utilisée pour les analyser et déclencher une alerte en cas de franchissement d'un seuil prédéterminé. Une fois l'alerte vérifiée par une enquête sur le terrain, l'événement était signalé au centre de commandement et de contrôle du système d'alerte sanitaire précoce dans chaque région du pays. Si une situation d'urgence ou un événement était signalé, le centre de commandement et de contrôle élaborait des rapports et des bulletins épidémiologiques programmés ou sur demande et les distribuait aux parties prenantes, notamment le Centre mondial de médecine des rassemblements de masse relevant du Ministère de la santé (centre collaborateur de l'OMS), le Ministère du Hajj et des partenaires extérieurs, dont l'OMS. Les rapports étaient également diffusés auprès du grand public si cela était jugé nécessaire.

Généralement, avec un système de surveillance bien établi, la préparation et la coordination de la surveillance commencent quelques mois avant le Hajj ; elles impliquent une collaboration entre les parties prenantes nationales et internationales, notamment le Ministère de la santé, le Centre mondial de médecine des rassemblements de masse, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre de prévention et de contrôle des maladies du Golfe et l'OMS. Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale complète ces activités en surveillant principalement les signaux internationaux à l'aide du système EIOS (31). L'OMS surveille la situation une semaine avant et une semaine après le jour du Hajj afin de détecter tout risque associé à l'événement et à l'exportation de maladies infectieuses parmi les pèlerins qui rentrent chez eux.

Références bibliographiques

1. Public health for mass gatherings: key considerations. Geneva: World Health Organization; 2015 (<https://www.who.int/publications/i/item/public-health-for-mass-gatherings-key-considerations>, consulté le 12 décembre 2024).
2. The United Nations Terminology Database. New York: United Nations; (<https://unterm.un.org/unterm2/en/>, consulté le 12 décembre 2024).
3. McCloskey B, Endericks T, Catchpole M, Zambon M, McLauchlin J, Shetty N et al. London 2012 Olympic and Paralympic Games: public health surveillance and epidemiology. *Lancet*. 2014;383:2083-9. doi: 10.1016/s0140-6736(13)62342-9.
4. Bieh KL, Khan A, Yezli S, El-Ganainy A, Asiri S, Alotaibi B et al. Implementing the Health Early Warning System based on syndromic and event-based surveillance at the 2019 Hajj. *East Mediterr Health J*. 2020;26:1570-5. doi: 10.26719/emhj.20.129.
5. Sugishita Y, Somura Y, Abe N, Murai Y, Koike Y, Suzuki E et al. Multisource surveillance conducted by the Tokyo Metropolitan Government during the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. *Western Pac Surveill Response J*. 2023;14:1-10. doi: 10.5365/wpsar.2023.14.3.978.
6. Blumberg L, Regmi J, Endricks T, McCloskey B, Petersen E, Zumla A et al. Hosting of mass gathering sporting events during the 2013-2016 Ebola virus outbreak in West Africa: experience from three African countries. *Int J Infect Dis*. 2016;47:38-41. doi: 10.1016/j.ijid.2016.06.011.
7. Jeong MH, Song YH, Ju SY, Kim SH, Kwak HS, An ES. Surveillance to prevent the spread of norovirus outbreak from asymptomatic food handlers during the PyeongChang 2018 Olympics. *J Food Prot*. 2021;84:1819-23. doi: 10.4315/jfp-21-136.
8. Détection précoce, évaluation et réponse lors d'une urgence de santé publique : mise en œuvre de l'alerte précoce et réponse notamment la surveillance fondée sur les événements : version provisoire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (<https://iris.who.int/handle/10665/144804>, consulté le 12 décembre 2024).
9. Archer BN, Abdelmalik P, Cognat S, Grand PE, Mott JA, Pavlin BI et al. Defining collaborative surveillance to improve decision making for public health emergencies and beyond. *Lancet*. 2023;401:1831-4. doi: 10.1016/s0140-6736(23)01009-7.
10. Signalement précoce, alerte et riposte dans les situations d'urgence : guide opérationnel Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2022 (<https://iris.who.int/handle/10665/376503>, consulté le 12 décembre 2024).
11. WHO Mass Gatherings All Hazards Risk Assessment Tool. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://partnersplatform.who.int/all-hazards-mass-gatherings-risk-assessment>, consulté le 12 décembre 2024).
12. The generic all-hazards risk assessment tool for mass gathering events. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2023-Generic-Mass-gatherings-All-Hazards-RAtool-2023-1>, consulté le 12 décembre 2024).
13. Jabbar R, Elshareif TJ, Mahadoon LK, Shami R, Ibrahim WN, Uzuagu ED et al. Enhancement of communicable disease surveillance during FIFA World Cup Qatar 2022™: A legacy. *Qatar Journal of Public Health*. 2024;2024. doi: <https://doi.org/10.5339/qjph.2024.2>.
14. Infectious disease risk assessment for the Tokyo Olympic and Paralympic Games (updated version) Tokyo: National Institute of Infectious Diseases, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan; 2021 (<https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/45/covid19-45-en.pdf>, consulté le 12 décembre 2024).
15. Ebola outbreak 2014–2016 – West Africa. Geneva: World Health Organization; 2024 (<https://www.who.int/emergencies/situations/ebola-outbreak-2014-2016-West-Africa>, consulté le 12 décembre 2024).
16. Zika (maladie à virus). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024 (<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus>, consulté le 12 décembre 2024).
17. Conseils de santé publique de l'OMS sur les Jeux olympiques et le virus Zika. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 (<https://www.who.int/fr/news/item/28-05-2016-who-public-health-advice-regarding-the-olympics-and-zika-virus>, consulté le 12 décembre 2024).
18. Déclaration sur la deuxième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la flambée de nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 ([https://www.who.int/fr/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/fr/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))), consulté le 12 décembre 2024).

19. Déclaration sur la quinzième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 ([https://www.who.int/fr/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-\(covid-19\)-pandemic](https://www.who.int/fr/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic), consulté le 12 décembre 2024).
20. Règlement sanitaire international (2005) : outil d'autoévaluation pour l'établissement de rapports annuels par les États Parties, deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/352719>, consulté le 12 décembre 2024).
21. Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005), third edition. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240051980>, consulté le 12 décembre 2024).
22. Bulletins d'information sur les flambées épidémiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, (<https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news>, consulté le 12 décembre 2024).
23. WHO Health Emergency Dashboard. Geneva: World Health Organization; updated (<https://extranet.who.int/publicemergency/>, consulté le 12 décembre 2024).
24. Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS). Berlin: World Health Organization Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence; 2024 (<https://www.who.int/initiatives/eios>, consulté le 12 décembre 2024).
25. ProMED. ProMED International Society for Infectious Diseases. (<https://promedmail.org/>, consulté le 12 décembre 2024).
26. Réseau mondial de renseignement de santé publique en bref. Ottawa, Agence de la santé publique du Canada, Gouvernement du Canada, non daté (https://gphn.canada.ca/cepr/aboutgphn-rmispenbref.jsp?language=fr_CA, consulté le 12 décembre 2024).
27. HealthMap. HealthMap: Virus and Contagious Disease Surveillance. updated (<https://www.healthmap.org/en/>, consulté le 12 décembre 2024).
28. Europe Media Monitor. European Commission's Joint Research Centre; updated (https://knowledge4policy.ec.europa.eu/online-resource/europe-media-monitor-emm_en, consulté le 12 décembre 2024).
29. Yanagawa M, Lorenzo JC, Fukusumi M, Shimada T, Kasamatsu A, Ota M et al. Use of Epidemic Intelligence from Open Sources for global event-based surveillance of infectious diseases for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. Western Pac Surveill Response J. 2022;13:1-7. doi: 10.5365/wpsar.2022.13.3.959.
30. Togami E, Griffith B, Mahran M, Nezu IH, Mirembe BB, Kaasik-Aaslav K et al. The World Health Organization's public health intelligence activities during the COVID-19 pandemic response, December 2019 to December 2021. Euro Surveill. 2022;27. doi: 10.2807/1560-7917.es.2022.27.49.2200142.
31. Health emergencies biweekly bulletin. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2024 (<https://applications.emro.who.int/docs/WHOEMCSR760E-eng.pdf?ua=1>, consulté le 12 décembre 2024).
32. EIOS Training. Berlin : World Health Organization Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence; 2024 (<https://www.who.int/initiatives/eios/eios-training>, consulté le 12 décembre 2024).
33. Règlement sanitaire international (2005), Troisième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (<https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241580496>, consulté le 12 décembre 2024).
34. Cadre d'action d'urgence : procédures internes de l'OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024 (<https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240058064>, consulté le 12 décembre 2024).
35. Cadre pour un centre d'opérations d'urgence de santé publique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (<https://www.who.int/fr/publications/i/item/framework-for-a-public-health-emergency-operations-centre>, consulté le 12 décembre 2024).
36. Hamblion E, Saad NJ, Greene-Cramer B, Awofisayo-Okuyelu A, Selenic Minet D, Smirnova A et al. Global public health intelligence: World Health Organization operational practices. PLOS Glob Public Health. 2023;3:e0002359. doi : 10.1371/journal.pgph.0002359.
37. Kasamatsu A, Ota M, Shimada T, Fukusumi M, Yamagishi T, Samuel A et al. Enhanced event-based surveillance for imported diseases during the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. Western Pac Surveill Response J. 2021;12:1-7. doi : 10.5365/wpsar.2021.12.4.903.

Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20
1211 Genève
Suisse

who.int